Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 7ª Vara Cível da Capital

, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0005337-93.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): CLARICE GOMES MAGALHAES, BRAZ COSME MAGALHAES, BRUNO COSME DE MAGALHAES, RAFAEL COSME DE MAGALHAES, FELIPE COSME DE MAGALHAES

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

-

EMENTA: DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO.

- Tratamento oncológico com previsão de cobertura diferenciada em normas (art. 12, I, "c", e II, "g", da lei 9.656/98) e jurisprudências pátrias. Precedentes do STJ de dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.

- Medicamento incorporado ao SUS, registrado na ANVISA, uso conforme indicação e prova de necessidade do uso do medicamento para tratamento.

- Diferenciação da prescrição de medicamento *off-label* do uso experimental. Medicamento *off-label* possui comercialização autorizada pela Anvisa e submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância, seu uso não fere as normas sanitárias. O medicamento já foi testado e aprovado pelas autoridades sanitárias, sendo apenas prescrito fora de seu propósito original.

- Obrigatoriedade de cobertura.

- Indenização por danos morais.

Vistos etc.

CLARICE GOMES MAGALHÃES, qualificada, mediante advogado, ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., igualmente identificada.

Requerendo o benefício da gratuidade da justiça e negando interesse na conciliação, expôs ser titular de contrato de assistência à saúde com a demandada, desde 12/2017, estando adimplente com suas obrigações contratuais.

Disse ser paciente oncológica, tendo, em 17/01/2020, sido diagnosticada pelo seu médico oncologista, Dr. Carlos Eduardo, como portadora de melanoma maligno CID10: C43, estágio IV (metástase para retroperitôneo, baço e linfonodo ilíaco), com mutação de BRAF V600E positiva detectada, tendo a si prescrito o uso das medicações Dabrafenib e Trametimib, tendo passado por diversos imbróglios para obter a referida medicação, precisando recorrer à Agência Nacional de Saúde, por meio do protocolo nº 7547025, em 21/05/2021, após reiteradas negativas e atrasos do plano em disponibilizar o medicamento.

Narrou haver sido prescrito, em 30/07/2021, novo tratamento por meio da medicação Nivolumab (Opdivo), tendo que ingressar com processo, em 03/03/2022, sob o nº 0021840-63.2022.8.17.2001, perante a Seção B da 18ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE, em que foi deferido o pedido de tutela de urgência que determinou à ré o fornecimento do medicamento Nivolumabe 183 MG, a cada 2 (duas) semanas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Apontou ter, em 28/08/2022, sido submetida a um novo exame PET-CT, que teve como conclusão: "*Estudo de PET/CT com FDG-18F sugestivo de neoplasia em atividade em formação expansiva na topografia da segunda porção do duodeno, em nódulos adjacentes e em linfonodos axilares à direita, retroperitoneais e na cadeia ilíaca externa esquerda. Formação nodular hipodensa na adrenal direita, descrita nos exames anteriores. Linfonodo discretamente hipermetabólico na cadeia poplítea esquerda*", com câncer ainda em estado de metástase por todos os órgãos do seu corpo, havendo progressão da doença, tendo o médico assistente solicitado o fornecimento da medicação Ipilimumabe, também negada pela operadora ré, o que gerou o ajuizamento do processo nº 0124881-46.2022.8.17.2001, em 10/10/2022, na Seção "B" da 16ª Vara Cível de Recife/PE, em que também foi deferido o pedido de tutela de urgência.

Aduziu que, em 04/01/2024, em consulta com o seu médico oncologista, Dr. Carlos Eduardo Jeronico da Silva, tomou conhecimento da progressão do seu câncer, em especial nos linfonodos mesentéricos e grave lesão no duodeno, o que ocasiona compressão de via biliar e acarreta icterícia, estando em iminente risco de morte, em decorrência das metástases ocasionadas pela progressão do melanoma, estágio IV (CID 10 C-43), havendo seu médico oncologista indicado, em caráter de urgência, tratamento com nova medicação Pembrolizumabe (Keytruda®), com dose total por aplicação de 200 mg, a cada 03 semanas, até que haja progressão da doença.

Colocou haver, em 04/01/2024, realizado a solicitação administrativa da medicação Pembrolizumabe (Keytruda®) à ré, o que gerou o protocolo de nº 0104774575, mas sem resposta até os dias atuais, medicamento que garante sobrevida de qualidade, livre das extremas dores ocasionadas pela progressão do câncer.

Acrescentou ter a operadora ré também negado, de forma expressa, o exame de análise de mutações do gene c-KIT e do N-RAS, prescrito pelo Dr. Jayme José Gouveia Filho, médico oncologista, inscrito no CRM/PE sob o nº 20.374, teste que permite a avaliação prognóstica do câncer, auxiliando a equipe médica no planejamento terapêutico, pois no DNA das células e tecidos cancerígenos, a presença da mutação NRAS pode indicar que certos medicamentos não serão eficazes no tratamento, sendo imprescindível a realização do exame.

Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que a demandada seja compelida a custear integralmente o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), na dosagem de 200 mg, a cada 03 semanas, até progressão da doença, bem como do exame de Análise de mutações do gene c-KIT e do N-RAS, conforme laudo e solicitação médicas. No mérito, pediu confirmação da tutela e indenização por danos morais de R$ 20.000,00. Acostou documentos.

Decisão deferindo o pedido de gratuidade da justiça e deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré autorize, no prazo de 48h (quarenta e oito horas): a) o tratamento indicado no laudo médico de id 158432413 (medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), na dosagem de 200 mg, a cada 03 semanas); b) o exame prescrito no laudo de id 158432414 (Análise de mutações do gene c-KIT e do N-RAS); até ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos moldes do art. 497, do CPC, até o limite de seu décuplo (id 158451815).

A parte autora informou descumprimento da liminar, pedindo, ao final, bloqueio da quantia equivalente ao procedimento (Id 158837248).

Decisão: "*Diante do descumprimento de ordem judicial informado nos autos e da urgência do caso em análise, determino a intimação da parte ré para comprovar em 24 horas o cumprimento integral da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (id. 158451815), sob pena de ser realizado bloqueio via sisbajud a fim de dar efetivação da tutela concedida. Desde já fica advertida a parte ré que o descumprimento da decisão acima identificada poderá ensejar majoração da multa ali estipulada, podendo, ainda, configurar ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa de até 20%(vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 77, inciso IV, parágrafos 1º e 2º, do CPC/15*" (id 159124713).

Certidão de decurso de prazo sem manifestação do réu (id 159797201).

Intimada, a parte autora ratificou o descumprimento da ordem judicial, informando que até a presente data não lhe foi fornecida a medicação para o tratamento. Acostou documentos.

Decisão: *"Determino, por conseguinte, o bloqueio judicial em conta de titularidade da demandada, por meio do SISBAJUD, da quantia indicada no orçamento apresentado pela empresa Pharmaimports (ID 159836650), o qual teve o menor valor orçado, para o tratamento equivalente a 1 ciclo de medicação, no total de R$ 35.980,00*" (id 159912527).

Peça pelo réu informando que distribuiu Agravo de Instrumento (id 160490083).

Contestação (id 160789089) afirmando haver a parte autora utilizado amplamente os serviços contratados sem restrições, conforme comprovado por sua ficha médica anexada, sendo as negativas de cobertura para a medicação e o exame genético pautadas na legislação (Lei nº 9.656/98), no contrato, e nas normas da ANS.

Destacou ser a medicação Pembrolizumabe (Keytruda®) experimental para o caso da parte autora, não possuindo indicação em bula para o quadro clínico, invocando entendimento do STJ de que a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS exige comprovação de necessidade por laudo médico, incapacidade financeira e registro na ANVISA para usos autorizados.

Afirmou não ter o exame "C KIT ANÁLISE MUTACIONAL" preenchido as diretrizes da ANS para cobertura obrigatória, sendo a técnica de análise NGS não contemplada pelas diretrizes, descabendo cobertura.

Argumentou não ser o contrato celebrado abusivo, cumprindo as exigências de clareza e destaque das cláusulas limitativas de direitos, conforme arts. 46 e 54 do CDC e arts. 423 e 424 do CC, sendo a limitação de cobertura às DUTs lícita e acordada entre as partes. Apontou ser a negativa de cobertura lícita e fundamentada nas normas da ANS e no contrato.

Sustentou não ter havido ato ilícito que justificasse o pleito de indenização por danos morais, pois mera discussão de cláusula contratual não configura dano moral, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e qualquer dano sofrido pela autora.

Requereu a total improcedência dos pedidos formulados pela autora e, alternativamente, a realização de perícia médica para análise técnica da pertinência do Pembrolizumabe (Keytruda®) frente ao caso clínico da autora e avaliação baseada nas diretrizes da ANS.

Juntou documentos.

Decisão mantendo as decisões de ids 158451815 e 159912527 e, diante da urgência do caso, tratando-se de descumprimento de tutela de saúde, deferindo o pedido formulado pela autora de expedição de alvará de transferência da quantia bloqueada para conta de titularidade da autora, indicada na peça de id 160799957 e determinando a intimação da parte autora para réplica e das partes para indicação de possibilidade de composição ou outras provas a produzir (id 161045984).

Pedido de designação de perícia pela parte ré (id 162116875).

Réplica acostando novo laudo médico (id 164298209).

Peça da parte autora expondo ser a medicação importada, e, em decorrência de todo o trâmite administrativo para sua obtenção, há lapso temporal entre a data de efetivação da compra e a entrega para aplicação, sendo a medicação adquirida pela autora em 28/02/2024, apenas entregue em 19/03/2024, pedindo a renovação do bloqueio para obtenção da medicação para o equivalente a 4 ciclos (cada ciclo tem a duração de 3 semanas), que corresponde a 12 semanas de tratamento, sendo para a compra direta de doses equivalentes a 4 ciclos de tratamento com Pembrolizumabe (Keytruda®), na dosagem de 200 mg, a cada 3 semanas, conforme indicado pelo médico assistente o importe de R$ R$ 143.920,00.

Determinação de bloqueio judicial em conta de titularidade da demandada, por meio do SISBAJUD, do valor de R$71.960,00, referente a 2 ciclos do tratamento deferido na decisão de id 158451815 (id 164747277).

Peça dos herdeiros de CLARICE GOMES MAGALHÃES, narrando ter a autora falecido em 27/03/2024, na instituição hospitalar da ré, em decorrência do melanoma metastático do qual era acometida, expondo que, desde a decisão que concedeu a tutela de urgência, em 19/01/2024, até a data em que a autora falecida teve acesso a primeira dose da medicação, em 20/03/2024, houve um lapso temporal de exatos 2 meses de mora da operadora ré em disponibilizar a medicação que garantia a sobrevida com qualidade da autora. Pediram a habilitação dos herdeiros e o julgamento da lide (id 174432635).

É o relatório, passo à decisão.

Sobrevindo a morte da parte em qualquer fase processual, será processada a habilitação quando houver interesse em sua sucessão no processo, seja pelos seus herdeiros, seja pelo espólio.

No caso sob foco os herdeiros já se habilitaram, pelo que não precisa o feito ser suspenso, eis que a prolação deste ato independe de qualquer providência das partes, devendo ser o feito suspenso apenas após este ato para habilitação dos herdeiros e início de prazo de recurso.

Sabe-se que não se deve praticar atos inúteis, que representarão atraso na marcha processual, como diz o artigo 370 do CPC (antigo artigo 130, CPC, com pequenas modificações):

> "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
>
> Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Ensina Vicente Greco Filho:

> "A segunda parte do art.130 é uma decorrência de poder do juiz de velar pela rápida solução do litígio. Deverá ele impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias."(Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, São Paulo, 1999, 14ª edição, Volume I, pág.228).

Leciona Vicente Miranda:

> "A emissão de um juízo judicial de admissibilidade ou de inadmissibilidade deste ou daquele meio de prova funda-se na necessidade de serem evitadas provas inúteis ou desnecessárias ou protelatórias, que aumentariam os gastos do processo e retardariam seu normal desenvolvimento e conclusão.Sistematizando a matéria, podemos afirmar que o juízo de admissibilidade da prova obedece a quatro condições: a previsão legal, a tempestividade, a necessidade e a idoneidade."(Poderes do juiz no processo civil brasileiro, Editora Saraiva, São Paulo, 1993, pág.213)."

É o que aqui se dá, pois, analisando os autos, verifico haver elementos suficientes à apreciação de mérito, uma vez que o ônus da prova restou delimitado na peça atrial, estando a causa madura para julgamento do processo/antecipado do mérito, pois se trata de matéria de direito, com provas nos autos, já observado o contraditório (art. 355, CPC).

Ressalto, outrossim, que apenas são produzidas provas que influenciem no convencimento do magistrado, quem dirige o processo e é o destinatário das provas.

Como leciona Cassio Scarpinella Bueno: "*É que na medida em que o juiz (...) estiver convencido das alegações das partes ou de terceiros, não há razão para se produzir qualquer prova".**[1]*** *(file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftn1)*

Assim já entendeu o egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco:

> "*Com efeito, o princípio fundamental da ampla defesa não produz o dever de efetivamente serem produzidas provas em um determinado processo, isso porque sua oportunidade e conveniência estarão sempre submetidas ao princípio do livre convencimento ou da persuasão racional do magistrado, podendo este decidir quais provas serão relevantes para o deslinde do conflito ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.*
>
> *Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que "o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é o suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. (AgRg no Ag 834.707/PR, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, julgado em 27/03/2007). In casu, o julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa. As questões de fato e de direito já se encontravam suficientemente esclarecidas pela prova documental acostada aos autos, sendo lícito ao magistrado conhecer diretamente do pedido (art. 330, I, do CPC).*
>
> *Ademais, infere-se dos autos que na audiência conciliatória o magistrado a quo anunciou o julgamento antecipado da lide, sem que qualquer das partes tenha se insurgido contra o referido pronunciamento. Desta forma, mostra-se totalmente despropositada a arguição de*

cerceamento de defesa suscitada pela apelante, na medida em que o seu desinteresse quanto à especificação de provas operou a preclusão da matéria. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NOVAS PROVAS. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. VALORAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS. PRODUÇÃO. DISPONIBILIDADE. DESISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS. REVISÃO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. - (...) - Tendo o recorrente feito valer a disponibilidade do direito à produção de provas, abrindo mão daquelas que, embora anteriormente requeridas e deferidas, até então não haviam sido produzidas, não há como admitir a sua alegação de cerceamento de defesa, apenas porque lhe sobreveio sentença desfavorável. - As Súmulas nºs 05 e 07 do STJ vedam o reexame do substrato fático probatório dos autos no âmbito do recurso especial. Recurso especial não conhecido. (REsp 810.667/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 05/11/2008). Assim, deve ser afastada a argüição de cerceamento de defesa." (Apelação nº 0002674-15.2011.8.17.0810 (0279844-3), 6ª Câmara Cível, Relator Des. Eduardo Augusto Paurá Peres, Julgado em 23/10/2012, DJe Edição nº 206/2012, 6/11/2012, p. 172)

DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA CONVERTIDA EM FEITO EXECUTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO POR INVALIDEZ. APELO IMPROVIDO. - Rejeição da preliminar de nulidade da sentença. Alegação de nulidade da sentença, em face do julgamento antecipado da lide, ao argumento de cerceamento de defesa, alegando que se fazia mister produção de prova pericial. Quanto a isso, percebe-se, da análise da douta sentença, que não há nulidade do processo por cerceamento de defesa por ter o magistrado se valido do instituto prescrito no art. 330, I do Código de Processo Civil. Os fatos objeto da demanda encontravam-se suficientemente demonstrados, de modo a dispensar produção de provas outras, vez que a solução do litígio poderia ser extraída das carreadas aos autos, restando aptas a embasar o convencimento do julgador. Com efeito, diante da concessão do benefício junto ao INSS, restou despicienda a realização de perícia para aferição da invalidez permanente. (...). - Ademais, conforme alhures explicitado, a concessão de aposentadoria pelo INSS se mostra suficiente a embasar o pleito do exeqüente, máxime tendo em conta o rigor com que referida autarquia previdenciária age para a concessão dos benefícios. - Ora, a concessão pelo órgão previdenciário é prova inequívoca da invalidez que acometeu o exequente, que, inclusive, fora submetido a intervenção cirúrgica por conta de um tumor maligno de boca, com metástase cervical. Com efeito, a invalidez deve ser havida por permanente quando o segurado se vê impossibilitado de exercer o labor para o qual estava apto antes de ser acometido pela enfermidade. Não tem como prosperar a alegação de que o segurado não se encontra impossibilitado de exercer outras profissões, até porque não é plausível exigir que o mesmo desenvolva aptidão para exercer atividade laborativa que nunca exerceu antes. - Por derradeiro, no que tange às argumentações deduzidas em sede de contrariedade ao apelo, não tem como prosperar. - A pena a que foi condenado o apelante, tendo em conta a interposição de embargos havidos por protelatórios, não impede o ajuizamento de quaisquer recursos. Apenas no caso de reiteração de aclaratórios protelatórios é que a multa eleva-se a 10%, e a interposição de outros recursos fica condicionada ao depósito de referido montante, o que não é o caso dos autos. - No mais, a ausência de qualificação do recorrido em autos de apelo, não tem o condão de macular a insurgência recursal, máxime porque o mesmo atingiu o seu desiderato, de explicitar, tempestivamente, as razões de reforma em que se baseia o apelante, tudo com espeque no art. 154 do CPC. - Negativa de provimento ao presente apelo, mantendo-se incólumes todos os termos da sentença combatida. - Por unanimidade, negou-se provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. (TJ-PE - APL: 40543 PE 71757-9, Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 09/05/2012, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 105)"

Da mesma forma o STJ:

"PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA POSTULADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 130, parte final). 2- A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de defesa. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da causa (Súmula nº 7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1351403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2011, DJe 29/6/2011)."

Assim, rejeito a prova requerida pela parte demandada, o que faço lastrada no entendimento da matéria, repetido em julgamentos diversos das cortes pátrias e na ideia de que o magistrado que preside também orienta a produção probatória e lhe cabe indeferir provas que não sirvam ao desfecho da lide.

Passo ao julgamento.

PLANO DE REFERÊNCIA, ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS E DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT):

A jurisprudência pátria vem sofrendo para estabelecer decisões em casos de cobertura de procedimentos por contratos de assistência à saúde, pois, de um lado, há toda uma gama de direitos estabelecidos em favor da saúde, personalidade e consumidor, havendo, porém, a necessidade de preservação da viabilidade econômica das empresas que ofertam tais pactos e do equilíbrio das contraprestações.

Para tanto, este juízo tem se amparado das normas que lastram ambas as vertentes e das normativas do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), criado pela Lei 9.656/1998, e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, instituída pela Lei 9.961/00, para regulação e fiscalização das atividades que garantam assistência suplementar.

O chamado Plano de Referência foi instituído pelo art. 10 da lei 9.656/98 como aquele com "*cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (...)"* (redação da MP 2.177-44/2001).

Afere-se que mesmo o plano de referência não possui cobertura ilimitada, pois há exceções de cobertura no próprio artigo e em regulamentações da ANS, o que é regulado hoje pela ANS, RN nº 465, de 24/02/2021.

Com relação ao Rol da ANS ser taxativo ou exemplificativo tínhamos divergências entre Turmas do Superior Tribunal de Justiça, pois a 4ª Turma, no REsp 1.733.013/PR, concluiu o que o Rol da ANS seria taxativo, enquanto a 3ª Turma, no RESP 1829583/SP, reafirmou seu entendimento pela não taxatividade do rol mesmo diante dos precedentes da 4ª Turma.

A Agência Nacional de Saúde – ANS, quando da atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, RN nº 465 [2] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftn2), de 24/02/2021, trouxe uma significativa modificação em sua redação, quando, substituindo a redação anterior que falava em listar a cobertura mínima

obrigatória, como na RN 428/2017, disse estar a estabelecer a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida, expondo em seu art. 2º que, "*para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos*", o que não constava na RN anterior:

RN nº 465, de 24/02/2021:

"Art. 1º Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998.
§1º Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica.
§2º A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT.
Art. 2º Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde."

RN nº 428, de 07/11/2017:

"Art. 1º Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, e naqueles adaptados conforme a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998."

Assim, apesar de a RN de 2021 acrescentar 69 novas coberturas, ela incluiu em sua redação que "*para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta RN e seus anexos*", estabelecendo sua taxatividade.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, em julgamento de 08/06/2022, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS, desobrigando as operadoras de saúde à cobertura de tratamentos ali não previstos. Foram, não obstante, ali fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, seja imperativo o custeio de procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

No que se refere às exceções, no julgamento do EREsp 1.886.929 foi decidido ser o plano de saúde obrigado a custear tratamento não contido no rol para um paciente com diagnóstico de esquizofrenia, e, no EREsp 1.889.704, foi entendido caber à operadora cobrir tratamento para pessoa com transtorno do espectro autista, porque a ANS já reconhecia a terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do rol de saúde suplementar[3] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftn3).

O STJ definiu as seguintes teses[4] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftn4):

"1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS."

Em relação às quatro condicionantes do item "4", a seção citou os enunciados 23, 33 e 97 das Jornadas de Direito em Saúde (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/03/e8661c101b2d80ec95593d03dc1f1d3e.pdf):

"ENUNCIADO Nº 23 Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de ofício, a esta agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio."

"ENUNCIADO Nº 33 Recomenda-se aos magistrados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e aos Advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - Conitec para auxiliar a prolação de decisão ou a propositura da ação. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)"

"ENUNCIADO Nº 97 As solicitações de terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS, tais como equoterapia, hidroterapia e métodos de tratamento, não são de cobertura e/ou custeio obrigatório às operadoras de saúde se não estiverem respaldadas em Medicina Baseada em Evidência e Plano Terapêutico com Prognóstico de Evolução."

Ressalto que sobreveio a Lei nº 14.454, de 21/09/2022, que modificou o art. 10 da Lei nº 9.656/1998, entendendo caber exceções ao rol da ANS, nos seguintes termos:

"Art. 10. (https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2022-09-21%3B14454!art2_cpt_alt1_art10) *.....*

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. (...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

À luz da nova legislação, cabível exceção ao rol condicionada a dois elementos: que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Após a publicação de tal lei, o Supremo Tribunal Federal, entendeu pelo não conhecimento das ações de controle de constitucionalidade ADPFs 986 e 990 e ADIs 7.088, 7.183 e 7.193, por perda do objeto por causa do advento da Lei n° 14.454/2022.

No entanto, está esse longe de ser assunto pacífico, pois na Terceira Turma do STJ, em 17/11/2022, no I Congresso do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), anunciou que o STJ reabrirá o debate sobre a natureza exemplificativa do rol de procedimento da ANS[5] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftn5) e a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) propôs, em 11/11/2022, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7.265, em face da nova lei, ainda pendente de julgamento pelo STF.

No voto condutor do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, quando do julgamento pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n° 1870834/SP, submetido ao rito dos repetitivos, Tema 1069, em julgado de 13/09/2023, assim consolidou:

"Como se verifica, a inovação normativa praticamente positivou os critérios delineados pela Segunda Seção do STJ, tornando o "rol taxativo mitigado" em "rol exemplificativo mitigado".

Em outras palavras, a Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.

Assim, com a edição da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.

Cabe ressaltar que os efeitos práticos do "rol taxativo mitigado" ou do "rol exemplificativo mitigado" serão similares, isto é, tais efeitos ultrapassam eventuais rótulos reducionistas.

*A respeito, confira-se o **Enunciado nº 109** das Jornadas de Direito da Saúde:*

> *"**Solicitado procedimento ou tratamento médico não previsto no Rol da ANS, cabe verificar, além das condições legais descritas no artigo 10, § 13 da Lei nº 9.656/98: a) se existe, para o tratamento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol da ANS; b) se não foi indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ou tratamento; c) se há expressa exclusão regulamentar ou legal em relação ao procedimento ou tratamento solicitado; d) se há notas ou pareceres técnicos de órgãos tais como a Conitec e o NatJus que avaliaram tecnicamente a eficácia, acurácia e efetividade do plano terapêutico**." (grifou-se)."*

Assim, entendeu aquela Corte Superior pela equivalência entre os termos *"rol taxativo mitigado"* e *"rol exemplificativo mitigado"*, mantendo seu posicionamento.

CASO CONCRETO – MEDICAMENTO ONCOLÓGICO:

Ressalto que o medicamento oncológico de uso domiciliar merece cobertura em qualquer forma de administração, conforme art. 12, I, "c", e II, "g", da lei 9.656/98, que estabeleceu tratamento diferenciado:

-

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)

I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art2) (Vigência) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art3)

II - quando incluir internação hospitalar: (...)

g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art2)".

A atenção diferenciada de hipóteses de tratamento oncológico é regra na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

-

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. COBERTURA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

*1. **A ja jurisprudência desta Corte reconhece que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante quando se tratar da análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.**2. Em relação à revisão dos honorários sucumbenciais, convém ressaltar que, de acordo com a orientação deste Tribunal de Uniformização, em virtude do quantitativo da verba honorária decorrer de uma análise específica dos fatos ocorridos durante a marcha processual, na qual o julgador avalia o trabalho desenvolvido pelo patrono e a complexidade da causa, a fim de fixar o percentual que considera correto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça revisar a quantia estabelecida, exceto quando constatada sua manifesta insignificância ou excessividade apta a afastar o óbice da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no REsp 1914870 / SP, **RELATOR**Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), T3 - TERCEIRA TURMA, j. 20/03/2023, DJe 22/03/2023)."*

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE RETO ALTO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

*1. **Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.***

*2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 2004990/SP, **RELATORA**Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023)."*

> *"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CÂNCER. RECUSA. **ROL** DE PROCEDIMENTOS DA **ANS**. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.*
>
> *1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)*
>
> *serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.*

> *2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no **rol** de procedimentos da **ANS**.*

> *3. **No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS** (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).*
>
> *4. No caso, o Tribunal distrital consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela beneficiária. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.º 7 do STJ.*

> *5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.*

> *6. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1987435/DF, Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j, 06/03/2023, DJe 09/03/2023)."* (grifos para destacar)

-

A tese da parte ré de caber aqui atenção ao Recurso Repetitivo – IRC – Tema: 106 do STJ, por ser uso do medicamento de caráter experimental, não merece atenção, pois, primeiramente, ali se tratou de obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o que não se aplica. Essa foi a tese firmada:

"Tese Firmada:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." (Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).

Em segundo lugar, cabe ser feita a diferenciação da prescrição de medicamento *off-label* do uso experimental, pois apenas nesse não há garantia e segurança previamente estabelecidos com relação à posologia e seus efeitos no corpo humano.

A prescrição *off-label* é a indicação de medicamento que tem comercialização autorizada pela Anvisa e foi submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância. Seu uso não fere as normas sanitárias. O medicamento já foi testado e aprovado pelas autoridades sanitárias, sendo apenas prescrito fora de seu propósito original.

Na maioria das vezes o medicamento apenas ainda não foi aprovado para determinada terapêutica no país, já tendo a referida indicação no exterior e muitas vezes tais indicações nunca constarão na bula por falta de ensaios clínicos necessários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende caber cobertura pelo plano de saúde à prescrição *off-label* em casos concretos justificados:

*"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento do medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali), necessário para tratamento oncológico. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2030294 MS 2021/0373400-7, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)" (*grifos paradestacar).

"RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO CLÍNICO OU CIRÚRGICO EXPERIMENTAL E MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. USO OFF LABEL. POSSIBILIDADE, EM SITUAÇÕES PONTUAIS. CONFUSÃO COM TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DESCABIMENTO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA, A RESPALDAR O USO. NECESSIDADE.

1. Por um lado, o art. 10, incisos I, V e IX, da Lei n. 9.656/1998, testilhando com a fundamentação da decisão recorrida, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. Por outro lado, no tratamento experimental, o intuito da pesquisa clínica não é propriamente tratar, mas alcançar resultado eficaz e apto ao avanço das técnicas terapêuticas atualmente empregadas, ocorrendo em benefício do pesquisador e do patrocinador da pesquisa.

2. O art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998, por tratar de questão atinente ao exercício profissional da medicina, deve ser interpretado em harmonia com o art. 7º, caput, da Lei n. 12.842/2013, que estabelece que se compreende entre as competências da autarquia Conselho Federal de Medicina - CFM editar normas "para definir o caráter experimental de procedimentos em Medicina", autorizando ou vedando sua prática pelos médicos.

3. Nessa linha, consoante deliberação do CFM, o uso off label justifica-se em situações específicas e casuísticas e ocorre por indicação médica pontual, sob o risco do profissional que indicou. É considerado como hipótese em que "o medicamento/material médico é usado em não conformidade com as orientações da bula, incluindo a administração de formulações extemporâneas ou de doses elaboradas a partir de especialidades farmacêuticas registradas; indicações e posologias não usuais; administração do medicamento por via diferente da preconizada; administração em faixas etárias para as quais o medicamento não foi testado; e indicação terapêutica diferente da aprovada para o medicamento/material".

4. Havendo evidências científicas que respaldem a prescrição, é universalmente admitido e corriqueiro o uso off label de medicamento, por ser fármaco devidamente registrado na Anvisa, aprovado em ensaios clínicos, submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância e produzido sob controle estatal, apenas não aprovado para determinada terapêutica.

5. Conforme propõe o Enunciado n. 15 da I Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, devem as prescrições médicas consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, da posologia, do modo de administração, do período de tempo do tratamento "e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica". 6. Assim, como a questão exige conhecimento técnico e, no mais das vezes, subjacente divergência entre profissionais da saúde (médico assistente do beneficiário e médico-perito da operadora do plano), para propiciar a prolação de decisão racionalmente fundamentada, na linha do que propugna o Enunciado n. 31 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, o magistrado deve "obter informações do Núcleo de Apoio Técnico ou Câmara Técnica e, na sua ausência, de outros serviços de atendimento especializado, tais como instituições universitárias, associações profissionais, etc".

7. A prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal, e nem mesmo a recorrente afirma que a utilização do fármaco traz algum risco de dano à saúde da autora ou que seja ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete. Portanto, e pela ausência de pedido de cassação da sentença para solicitação de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e/ou produção de prova pericial para demonstração da inexistência de evidência científica (clínica) a respaldar a prescrição do medicamento, é de rigor a confirmação da decisão recorrida, ainda que por fundamento diverso.

8. Recurso especial não provido." (REsp 1729566/SP, RELATORMinistro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 04/10/2018, DJe 30/10/2018).

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo

*Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. **É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label.** 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1989283 RN 2022/0050242-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)"*(grifos paradestacar).

O medicamento Pembrolizumabe tem registro na ANVISA[6] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftn6) como antineoplásico e é indicado "*para o tratamento de primeira linha de pacientes com adenocarcinoma gástrico ou da junção gastroesofágica (GEJ) localmente avançado, irressecável ou metastático, HER2-positivo, em combinação com trastuzumabe e quimioterapia contendo fluoropirimidiana e platina, cujos tumores expressam PDL1 com pontuação positiva combinada (PPC) ≥ 1, conforme determinado por exame validado. O medicamento KEYTRUDA® (pembrolizumabe) possui indicação aprovada para uma ampla gama de doenças oncológicas como melanoma, carcinoma urotelial, carcinoma de células renais, câncer endometrial, entre outros, conforme especificações definidas em bula*", conforme site da ANVISA.

A hipótese de tratamento da bula contempla o que resta descrito no laudo sob id 158432413, por ser a parte autora portadora de portadora de melanoma metastático, estágio IV (CID 10 C-43), narrando o médico assistente que a "*Paciente apresenta progressão de doença importante, como em linfonodos mesentéricos e grave lesão em duodeno com compressão de via biliar acarretando icterícia. Todas secundárias a metástases de melanoma, **correndo grave risco de morte**. Necessita urgentemente de nova medicação, pois apresentou franca progressão de doença durante tratamento anterior*", inclusive havendo prova ter sido já submetida a tratamentos com outros fármacos, mas sem sucesso:

"Declaramos para os devidos fins que a paciente CLARICE GOMES MAGALHAES, REG: 521041 CPF: 165.254.694.49 é portadora de MELANOMA MALIGNO CIDIO: C43, estágio IV (Metástases para retroperitôneo, baço e linfonodo ilíaco), com mutação de BRAF V600E positiva detectada. No momento, paciente com grande volume de doença conforme PET-CT de 02/12/2019, mantendo bom performance clínico (ECOG: 1) e tem necessidade do tratamento com urgência das medicações DABRAFENIB E TRAMETINIB.
O benefício do uso de tais medicamentos foi comprovado em estudo Fase III publicado no The New England Journal of Medicine e atualizado em agosto de 2019 (N Engl J Med 2019;381:626-636) que mostrou que terapia combinada de DABRAFENIB E TRAMETINIBapresenta melhora significativa na sobrevida livre de progressão de doença e Sobrevida Global em pacientes com melanoma e mutação do BRAF positiva, como a paciente supracitada.
Portanto, solicitamos que a paciente faça uso de DABRAFENIB 150 mg - 01 comprimidoVO, de 12/12h CONTINUO e TRAMETINIB 2mg - 1 comprimido, VO, uma vez ao diaCONTINUO até progressão de doença ou toxicidade limitante (por tempo indeterminado).
Destacamos que devido seu alto custo, não é possível fornecê-los via APAC ou hospitalar, motivo deste pedido por estarmos convencidos do benefício clínico para este paciente, bem como fármaco economicamente recomendável. Tais medicações ainda não fazem parte do rol de medicações excepcionais do ministério da saúde e /ou secretaria estadual e vem sendo fornecidas em todo país via liminar a quem procura seu direito constitucional à saúde.
O atraso no fornecimento desta medicação implica risco de progressão de doença, piora clínica e óbito para o paciente." (id 158432413).

Impende ser analisado o histórico da parte autora, acima narrado, com diversos tratamentos desde a descoberta do câncer, em 17/01/2020, contando de laudo médico que autora "*apresenta progressão de doença importante, como em linfonodos mesentéricos e grave lesão em duodeno com compressão de via biliar acarretando icterícia. Todas secundárias a metástases de melanoma, correndo grave risco de morte. Necessita urgentemente de nova medicação, pois apresentou franca progressão de doença durante tratamento anterior*" (id 158432413).

O médico assistente, diante da evolução da moléstia, prescreveu o uso de Pembrolizumab, sendo essa a indicação clínica que, diante da hipótese dos autos, é a única a lhe conferir chances de melhora, cabendo a excepcionalidade ao caso, diante de tudo que já foi aqui exposto.

Inexiste, dessa forma, desatenção ao julgado do Recurso RepetitivoIRC Tema: 106 do STJ.

Assim, a parte autora preenche os requisitos, cabendo cobertura integral do medicamento.

Por conseguinte, com a mesma fundamentação cabível a cobertura ao exame de Análise de mutações do gene c-KIT e do N-RAS.

DANO MORAL:

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, é necessária a existência de uma lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio moral e, dependendo da situação prescinde a sua demonstração em juízo (*in re ipsa)*.

Nesse sentido a precisa doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

> "Uma das mais relevantes questões nas ações indenizatórias é a prova do dano, por serele, como visto, requisito indispensável para a reparação. Nesse sentido adverte AgostinhoAlvim: "Grande número de vezes o credor não consegue cobrir-se dos prejuízos totais, nãopor causa da lei, que lhe dá tudo, mas por causa do rigor da prova exigida." Completa oMestre: "Sempre se reconheceu haver situações difíceis e provas quase que impossíveis deproduzir com precisão, dada a natureza dos fatos. O princípio da reparação do dano exigeque se tenha em vista todas as circunstâncias que rodeiam o caso, não sendo possível traçar,a priori, regras fixas, que invariavelmente se ajustam a todas as hipóteses."E como, de regra,não se presume o dano, esta é uma questão que deve merecer redobrada atenção de quembusca uma indenização em juízo.
>
> Cumpre, então, lembrar que uma coisa é a prova do dano, do fato lesivo, da efetivaviolação do dever jurídico, e outra é a provado valor da indenização. Tanto assim que aefetividade do dano e o cálculo da indenização podem ser apreciados em duas fases distintas.Na primeira, prova-se a existência do dano, a efetiva ocorrência do fato lesivo e a responsabilidade de seu causador (an debeatur); na segunda, busca-se fixar a extensão do dano, asua quantificação, o valor da indenização (quantum debeatur). Isso se torna mais evidentenos casos de interesses ou direitos individuais homogêneos, os que decorrem de origemcomum (CDC, art. 81, III). Na ação coletiva prova-se o fato lesivo comum (an debeatur),cabendo depois, a cada vítima, promover a execução, na qual deverá ser apurado o valor daindenização de cada uma (quantum debeatur).
>
> Como se prova a existência do dano? Ora, se dano é lesão de um bem ou interesse juridicamente tutelado (e aí está a importância dos conceitos), prova-se o dano provando-se a ocorrência do fato lesivo (v. g., o acidente, a morte do ente familiar, o fato do produto ou do serviço, o fato ofensivo à honra etc.) por qualquer meio de prova em juízo admitido - documental, testemunhal, pericial etc. Tanto o dano patrimonial como o dano extrapatrimonial exigem a prova do fato lesivo. Por isso se diz que dano certo é aquele cuja existência acha-se provada, de tal modo que não pairam dúvidas quanto à sua ocorrência.

Não basta, portanto, simplesmente alegar a existência de um fato lesivo sem fazer prova de sua efetiva ocorrência, mesmo porque não cabe à contraparte fazer prova de fato negativo.

Sem prova efetiva do fato lesivo e da responsabilidade do agente, repita-se, a ação indenizatória estará irremediavelmente prejudicada, mas, demonstrada a existência do fato danoso, restaao prejudicado o direito à indenização. Provado o fato lesivo a bem patrimonial ou moral,que ficará o dano estará ínsito na própria ofensa, decorrerá da gravidade do ilícito em si. O pendente de apuração será o valor da indenização, o quantum debeatur. Esse é o sentido do entendimento da doutrina e da jurisprudência no que respeita à existência do dano moral in re ipsa. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação

de ordem pecuniária ao lesado. Compreende-se que assim seja porque a lesão ou gravame no plano moral nem sempre se materializa no mundo físico, por essa razão prescindindo de provas. Mas o fato gravoso e os reflexos que a sua potencialidade ofensiva irradia terão que ser comprovados.

Em outras palavras, só se justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado quando há efetiva ocorrência de fato grave e ofensivo. O dano moral nesse caso existirá in re ipsa, decorrerá inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto estará demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural,uma presunção hominis ou facti que decorre das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provada a perda de um filho, do cônjuge, ou de outro ente querido, não há que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio fato de acordo com as regrasde experiência comum; provado que a vítima teve o seu nome aviltado, ou a sua imagemvilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está in re ipsa;decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato,provado está o dano moral.

A Terceira Turma do STJ deu correta aplicação a esta questão: "Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há falar em prova; o que se deve provar é o fato que gerou a dor, o sofrimento.Provado o fato, impõe-se o dano in re ipsa". No mesmo sentido decidiu novamente a Terceira Turma: "Nos casos de protesto de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes,o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." Por último, a Quarta Turma: "Inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito. Dano moral presumido. Desnecessidade de comprovação. Obrigação de indenizar".

Como bem observa Anderson Schreiber, "Nestas situações, diz-se com frequência que ojuiz recorre a presunções de dano. Não parece ser tanto este o caso. O juiz não observa simplesmente a notícia e a partir dela extrai a ilação de que tenha ou não causado dano à honra da vítima. Ao contrário, o juiz observa a notícia e verifica, objetiva e concretamente, se sua veiculação lesa a honra da vítima, perquirindo, por exemplo, se a notícia emprega contra o autor da demanda expressões difamatórias, se alude ao seu caráter, se lhe dirige ofensa pessoal. Eis como se prova a lesão e, portanto, o dano. Se a vítima se lamentará do fato, se sofrerácom ele, ou se lhe demonstrará indiferença são questões subjetivas que podem, no máximo,servir de indícios da intensidade do dano para fins de sua quantificação, mas não interferemtecnicamente na sua reparação."

(...)

Por fim, a lição de Xisto Tiago de Medeiros Neto: "A certeza do dano emerge objetivae diretamente do evento causador (ipso facto), o que se faz compreensível nos domínios dalógica. que não se pode pretender provar eventuais efeitos da violação (aspectos comoinsegurança, transtorno ou abalo coletivo), uma vez que estes são consequências que têmrealidade apreendida a partir do senso comum".

Mas, lembre-se, esse entendimento não se aplica a qualquer ato ilícito. Não cabe falarem dano moral in re ipsa quando o fato narrado está no contexto de meros dissabores, sem qualquer agressão à dignidade ou ofensa a atributo da personalidade. Para se presumir o dano moral pela simples comprovação do fato, esse fato tem que ter a capacidade de causar dano, o que se apura por um juízo de experiência. Nesse sentido também está assentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CADASTRO DE CORRENTISTAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

Depreende-se dessa síntese doutrinária e jurisprudencial que o dano moral, embora prescinda de prova, o que se convencionou chamar de dano in re ipsa, deve ser aferido em face do caso concreto e não em tese. Será sempre indispensável a efetiva ocorrência de fato realmente ofensivo a bens e valores da personalidade para se admitir a existência do dano in re ipsa.

I - Para se presumir o dano moral pela simples comprovação do ato ilícito, esse ato deveser objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos.

II - Hipótese em que, não obstante ser incontroversa a ocorrência do ato ilícito, não restou comprovado que de tal ato adveio qualquer consequência capaz de configurar o dano moral que se pretende ver reparado.

Depreende-se dessa síntese doutrinária e jurisprudencial que o dano moral, embora prescinda de prova, o que se convencionou chamar de dano in re ipsa, deve ser aferido em face docaso concreto e não em tese. Será sempre indispensável a efetiva ocorrência de fato realmenteofensivo a bens e valores da personalidade para se admitir a existência do dano in re ipsa."[7] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftn7)

Especificamente ao caso, coloco que a jurisprudência do STJ vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada[8] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftn8).

Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco observa restar configurado o dano moral, pelo sofrimento e abalo psíquico-econômico experimentado pelo paciente, ao ser desprotegido pelo plano em momento de grande fragilidade física e emocional[9] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftn9).

No tocante ao valor da indenização, entendo que conferir valor ao dano moral é tarefa árdua, eis que não se pode valorar a dor da agressão ao direito de personalidade imposta a alguém, assim, a jurisprudência pátria tem fixado parâmetros de modo a se ter uma compensação amenizadora, não irrisória e nem exacerbada.

Entendo, porém, que o valor da indenização deve ser adequado às peculiaridades do fato em questão, atendendo à repercussão do dano na esfera íntima do ofendido, às circunstâncias do fato em si, sua extensão.

No caso sob foco, ressaltando os fatos acima já narrados, e levando em consideração, outrossim, o potencial econômico-social do ofensor, de forma a inibir tal comportamento, ou seja, verdadeiro *desestímulo* a ponto de demovê-lo de novas práticas lesivas da mesma espécie ou diversa, tendo caráter não punitivo, mas pedagógico.

Adoto esse entendimento, ressalto, sob o exemplo do Superior Tribunal de Justiça, quando em seus julgados em que ressalta o caráter pedagógico do dano moral, visando exatamente o que dito acima, inibir outros comportamentos lesivos de igual forma (*EREsp 748868/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 25/03/2009, DJe 06/04/2009 / Esp 910794/RJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, j. 21/10/2008, DJe 04/12/2008 - REsp 763531 / RJ SEGUNDA TURMA Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS25/03/2008 DJe 15/04/2008*).

Assim, diante de tudo que foi acima exposto, fixo em R$ 10.000,00 o valor a ser indenizado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto julgo procedente o pedido para:

a) confirmar a tutela de id 158451815;

b) condenar a parte demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária com base na tabela do ENCOGE e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN), ambos contados a partir desta data, eis que apenas aqui fixado o *quantum* devido(Súmula 362, STJ e REsp nº 888.751 - BA (2006⁄0207513-3) – DJe 27/10/2011)[10] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftn10);

c) condenar a parte demandada ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador adversário, estes fixados em 10% do valor total da condenação (valor do tratamento orçado na inicial e valor de condenação por danos morais),com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se o pagamento integral das custas processuais da fase de conhecimento e arquivem-se os autos.

Em não tendo ocorrido pagamento das custas, intime-se a parte sucumbente para efetuar o pagamento das custas processuais, no prazo de quinze dias, sob as penalidades da lei.

Em não havendo manifestação, à secretaria para efetuar os cálculos dos valores anteriormente mencionados e, em seguida, oficie-se à Procuradoria do Estado, para as devidas providências legais, e à Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Comitê Gestor de Arrecadação, nos termos dos Provimentos nº 007/2019 - CM, de 10 de outubro de 2019, e nº 003/2022-CM, de 10 de março de 2022.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife, 23 de julho de 2024.

IASMINA ROCHA

Juíza de Direito

---

[1] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftnref1) Curso sistematizado de direito processual civil. Vol 2. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 170.

[2] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftnref2)Disponível em: <http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDAzMw==#ANEXOS (http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDAzMw==#ANEXOS)>Acesso em 12/03/2021.

[3] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftnref3)https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx)> Acesso em 29/06/2022.

[4] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftnref4)https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx)> Acesso em 29/06/2022.

[5] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftnref5) Disponível em: https://www.conjur.com.br/2022-nov-17/turma-stj-retomara-debate-rol-ans-lei (https://www.conjur.com.br/2022-nov-17/turma-stj-retomara-debate-rol-ans-lei)>.Acesso em 21/11/2022.

[6] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftnref6)https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/keytruda-r-pembrolizumabe-nova-indicacao-7 (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/h%20https:/www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/opdivo-r-nivolumabe-nova-indicacao-3%20/)> acesso em 05/07/2024.

[7] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftnref7)CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 16ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2023, págs. 113/115.

[8] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftnref8)STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021; AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020; REsp 986.947/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11.03.2008, DJ 26.03.2008 p. 1

[9] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftnref9)TJ-PE - AC: 00321003920218172001, Relator: JOAO JOSE ROCHA TARGINO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)); TJ-PE - AC: 5366010 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 30/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019; AC 115577-1 – Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio – DJPE 13.06.2007

[10] (file:///C:/Users/ir/Downloads/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20-%20Experimental%20-%20Off%20Label%20-%20Anvisa%20-%20Rol%20ANS%20-%20Pembrolizumabe%201.docx#_ftnref10)
"Caracterizado o dano moral, mostra-se compatível a fixação da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. Em razão do prolongado decurso do tempo, nesta fixação da reparação a título de danos morais já está sendo considerado o valor atualizado para a indenização pelos fatos ocorridos, pelo que a correção monetária e os juros moratórios incidem a partir desta data."

Assinado eletronicamente por: IASMINA ROCHA
23/07/2024 12:25:25
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 176636434

24072312252484800000172394166

IMPRIMIR GERAR PDF